

Stopa po unieruchomieniu / po gipsie

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Odzyskanie ruchomości stawu skokowego, kontroli stopy, siły łydki i pewnego obciążania po zakończeniu unieruchomienia.

Uwaga kliniczna
Zakres obciążania musi być zgodny z zaleceniem lekarza prowadzącego. Narastający obrzęk, zaczerwienienie lub ból łydki wymagają oceny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - odciążony - wariant funkcjonalny

Z podporu unieś biodra, pozostaw kolana ugięte i przenoś delikatnie ciężar między stopami. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez forsowania pięty. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Góra z równym obciążeniem - wariant funkcjonalny

Stań przy podparciu i stopniowo wyrównuj ciężar na obu stopach. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie unikaj stopy, ale też nie przekraczaj zaleceń obciążania. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Alfabet stopą - wariant funkcjonalny

Siedząc wykonuj stopą małe ruchy jak przy pisaniu liter alfabetu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch z kostki, nie całej nogi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Kolano do ściany w wyroku funkcjonalnym

Przy pięcie na podłożu przesuwaj kolano w stronę ściany i wracaj. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez ostrego bólu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jednonóż przy podparciu - wariant funkcjonalny

Przenieś ciężar na leczoną nogę i utrzymaj równowagę przy ścianie lub blacie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie progresuj, jeśli obrzęk wyraźnie narasta. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.